TEMA 54 · Seguridad del paciente. Sistemas de notificación de incidentes. Calidad de la asistencia sanitaria. Indicadores de calidad. Humanización de los servicios sanitarios

Resumen OPE Enfermería SMS · Taxonomía (circunstancia de riesgo, cuasi-incidente, incidente sin daño, evento adverso, centinela), Estrategia de Seguridad del SNS, prácticas seguras, SiNASP y matriz SAC, ACR y AMFE, Donabedian y PDCA, dimensiones de la calidad, indicadores e INDICAS, Proyecto HU-CI y EPICEE

1. Conceptos de seguridad del paciente

- **Seguridad del paciente (OMS)**: reducir el riesgo de **daño innecesario** asociado a la atención sanitaria **hasta un mínimo aceptable**.

Término	Definición	Ejemplo
Circunstancia de riesgo (condición latente)	Situación con potencial de daño, **sin incidente**	Pasillo mal iluminado, ratio insuficiente
Cuasi-incidente (*near miss*)	Error **interceptado antes de llegar al paciente**	Se detecta la medicación equivocada antes de administrarla
Incidente sin daño	El error **llega al paciente pero no le causa daño**	Dosis doble de paracetamol sin consecuencias
Evento adverso	Incidente que **causa daño** (lesión, prolongación de la estancia) derivado de la asistencia, no de la enfermedad	Flebitis por extravasación, infección quirúrgica, UPP adquirida, caída con contusión
Evento centinela	Suceso inesperado con **muerte o daño grave permanente**; exige **investigación inmediata (ACR)**	**Cirugía en el lado equivocado**, **potasio en bolo**, **suicidio de un paciente ingresado**

- Regla: **¿el error llegó al paciente?** No → **cuasi-incidente**; sí, sin daño → **incidente sin daño**.

2. Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS

- El manual la sitúa en el periodo **2025-2035** y la organiza en líneas: **cultura de seguridad**, factores humanos y formación (**cultura justa**, notificar sin represalias); **prácticas clínicas seguras**; **gestión de riesgos e incidentes**; **implicación de pacientes y cuidadores** (el «último eslabón»); **ámbitos específicos** (primaria, urgencias, salud mental, pediatría); y **gobernanza e investigación**.
- **Prácticas seguras**:
- **Uso seguro del medicamento**: **conciliación** de la medicación al ingreso y al alta; **medicamentos de alto riesgo** (insulinas, anticoagulantes, **cloruro potásico concentrado**, opioides, citostáticos) con **doble verificación independiente**.
- **Identificación inequívoca**: **pulsera** desde el ingreso y **preguntar al paciente su nombre completo y fecha de nacimiento** (pregunta abierta), contrastándolo con la pulsera; **nunca** «¿es usted el señor Martínez?».
- **Comunicación estructurada SBAR/SAER**: **S**ituación, **A**ntecedentes, **E**valuación, **R**ecomendación.
- **Cirugía segura**: listado de verificación de la OMS (la **profilaxis antibiótica** se comprueba en la **pausa quirúrgica**).
- **Prevención de UPP** (Braden **6-23**, alto riesgo **≤ 12**) y de **caídas** (**Downton > 2** alto riesgo; **Morse ≥ 45** alto riesgo). En Braden **menos puntos = más riesgo**; en Downton **más puntos = más riesgo**.
- **Proyectos Zero** e **higiene de manos** (Bacteriemia, Neumonía, ITU Zero). En el CVC, **clorhexidina alcohólica al 2%** dejando **secar al aire**.
- **Gestión de riesgos**: **análisis causa-raíz (ACR)**, **retrospectivo**, tras eventos centinela o graves (diagrama de **Ishikawa** o espina de pez); **AMFE** (análisis modal de fallos y efectos), **prospectivo**, antes de implantar un proceso o tecnología nuevos.

3. Notificación de incidentes: SiNASP

- **Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente**: web, de ámbito nacional pero **orientación local** (aprender en el propio centro). Busca **fallos del sistema**, no culpables.
- Principios: **voluntario**, **no punitivo** (separado de cualquier régimen sancionador), **confidencial**, **anónimo** o nominativo con **desidentificación** posterior (el manual cita **15 días**), orientación **sistémica**, **aprendizaje y mejora local** con retorno de la información.
- Se notifican **incidentes que no llegaron al paciente, incidentes sin daño y eventos adversos**. **Se excluyen** las **infracciones intencionadas**, **sabotajes**, **abusos** al paciente y el trabajo **bajo efectos del alcohol o drogas** (vía disciplinaria o judicial).
- **Matriz SAC** (probabilidad × gravedad): **SAC 1** riesgo extremo (muerte o daño permanente) → **ACR urgente**; SAC 2 alto; SAC 3 medio; **SAC 4 bajo** (cuasi-incidentes, fallos administrativos).
- Fases: **detección y notificación** → cribado y clasificación (SAC) → **análisis** (ACR o AMFE) → **implantación de mejoras** → **retroalimentación** a los profesionales.

4. Calidad asistencial

- **Donabedian**: evaluar la calidad en **estructura** (recursos humanos y materiales, organización: **ratio enfermera/paciente**, colchones antiescaras, dotación del carro de parada), **proceso** (lo que se hace y cómo: **cumplimiento de la higiene de manos**, **valoración del riesgo al ingreso**, aplicación de protocolos) y **resultado** (efecto en la salud: **prevalencia de UPP**, **tasa de caídas**, infecciones, mortalidad, reingresos, **satisfacción**).
- **Ciclo de Deming (PDCA)**: **P**lanificar → **H**acer (pilotaje) → **V**erificar (medir con indicadores) → **A**ctuar (estandarizar o corregir); es **circular y continuo**.

Dimensión de la calidad (Donabedian)	Significado
Eficacia	Beneficio en **condiciones ideales o experimentales** (ensayo clínico)
Efectividad	Resultado en la **práctica real** habitual
Eficiencia	Máximo resultado con el **menor coste**
Optimización	Punto de **máximo equilibrio entre beneficio y coste**
Aceptabilidad	Adecuación a las **expectativas y preferencias** del paciente
Legitimidad	Aceptación por la **sociedad** y sus valores
Equidad	Distribución **justa** según la necesidad, sin discriminación

5. Indicadores de calidad

- Un indicador mide el **grado de cumplimiento de un estándar**; permite vigilar tendencias, detectar desviaciones y compararse (**benchmarking**). Características: **relevancia, validez** (mide lo que pretende), **fiabilidad** (mismo resultado entre observadores), **sensibilidad** (detecta cambios), **especificidad** (capta solo lo que depende de la intervención) y **factibilidad** (fácil de obtener).
- **INDICAS** (sistema de indicadores de calidad): incluye indicadores **sensibles a la práctica enfermera**.
- Fórmulas:
- **Prevalencia de UPP** = pacientes con UPP en el corte / pacientes evaluados × **100**.
- **Incidencia de caídas** = caídas en el periodo / **días de estancia** × **1.000**.
- **Tasa de flebitis** = pacientes con flebitis / pacientes con vía venosa × **100**.
- **Hacer la escala o aplicar el protocolo = indicador de proceso**; **la UPP o la caída que aparece = resultado**.
- Prácticas de calidad: muestra de orina de una sonda **por el puerto de muestras con aguja**, **sin abrir el circuito cerrado**; higiene diaria del **meato con agua y jabón** (no antisépticos de rutina).

6. Humanización

- **Proyecto HU-CI** («humanizando los cuidados intensivos»): **≈ 160 buenas prácticas** certificables (AENOR) de nivel **básico, avanzado y excelente**. **8 líneas**: 1. **UCI de puertas abiertas** (visitas flexibles). 2. **Comunicación** (información en espacios privados, lenguaje claro). 3. **Presencia y participación de la familia** en los cuidados. 4. **Bienestar del paciente** (dolor, sedación ligera, sueño, ruido, luz natural, **minimizar las sujeciones mecánicas**). 5. **Cuidados al profesional** (**burnout**, fatiga por compasión, *debriefing*). 6. **Síndrome post-UCI** (secuelas físicas, cognitivas y psicológicas del superviviente; consultas de seguimiento). 7. **Infraestructura humanizada** (luz natural, boxes individuales, salas para familias y de duelo). 8. **Cuidados al final de la vida** (acompañamiento, nadie muere solo, sedación paliativa, duelo).
- En el SMS, las **comisiones de humanización** están en las **9 áreas de salud** y son **mixtas** (atención primaria y hospitalaria).
- **Malas noticias: EPICEE** (SPIKES, Baile y Buckman): **E**ntorno (lugar privado, sentados, sin interrupciones) → **P**ercepción («¿qué le han contado?») → **I**nvitación (cuánta información desea; derecho a no saber) → **C**onocimiento (dar la noticia con frase de aviso, sin tecnicismos) → **E**mpatía (validar emociones, silencios) → **E**strategia (resumen y plan).

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Cuasi-incidente = no llega al paciente; incidente sin daño = llega sin daño; evento adverso = daño.**

! **Centinela = muerte o daño permanente (lado equivocado, potasio en bolo, suicidio) → ACR.**

! Identificación: **pregunta abierta** (nombre y fecha de nacimiento) + **pulsera**.

! Alto riesgo (K^+, insulina, anticoagulantes, opioides, citostáticos) → **doble verificación**.

! SBAR/SAER: **S**ituación, **A**ntecedentes, **E**valuación, **R**ecomendación.

! Downton **> 2** y Morse **≥ 45** = alto riesgo de caídas; Braden **≤ 12** alto riesgo de UPP.

! **ACR retrospectivo; AMFE prospectivo; Ishikawa = espina de pez.**

! SiNASP: **voluntario, no punitivo, confidencial, anónimo**, aprendizaje local; **excluye dolo, sabotaje, abuso y alcohol o drogas**.

! SAC **1** = extremo → ACR; SAC **4** = bajo.

! Donabedian: **estructura** (ratio), **proceso** (cumplir la escala), **resultado** (UPP, caídas).

! **Eficacia = ideal**; **efectividad = real**; **eficiencia = coste**; optimización = **equilibrio**.

! PDCA: **planificar, hacer, verificar, actuar**, en ciclo continuo.

! Caídas: tasa **por 1.000 días de estancia**; UPP y flebitis **× 100**.

! Orina de una sonda: **por el puerto**, sin abrir el circuito; meato con **agua y jabón**.

! HU-CI: **8 líneas**; prácticas **básica, avanzada y excelente**; sujeciones = **bienestar**; burnout = **profesional**; secuelas = **post-UCI**.

! EPICEE: la **primera E es Entorno**; antes de dar la noticia, **Percepción e Invitación**.